

Marin Vaher, Mikk Oja, Katri Abel-Ollo, Aljona Kurbatova

Tervise Arengu Instituudi uimastite ja sõltuvuste keskus

Uimastite tarvitamise põhjused ja levimus

Artiklist saab ülevaate, mis on uimastite tarvitamise peamised põhjused, millised ained on Eestis rohkem levinud ja kust leiab infot või abi uimastitega seotud küsimustes.

Uimastid on ained, mis mõjutavad enesetunnet, käitumist ja ümbritseva maailma tajumist. Uimasteid liigitatakse nende toime, tarvitamise põhjuse ja legaalse staatuse järgi. Alkohool ja nikotiini sisaldavad tubakatooted on täiskasvanutele lubatud uimastid, seevastu narkootikumid on Eestis ebaseaduslikud¹. Alkohool ehk etanool on üks aine, ebaseaduslike uimastite hulka aga kuuluvad väga mitmesugused ained, mis avaldavad inimese kehale ja tajule üsna erinevat mõju. Need võib jagada järgmistesse gruppidesse:

- kannabinoidid – võivad olla nii ergutava kui ka uimastava toimega;
- stimulandid – ergutava toimega, nt amfetamiin, kokaiin;
- depressandid – kesknärvisüsteemi pärssiva toimega, nt GHB, olmekeemia;
- empatogeenid – suhtlemis- ja empaatiavõimet suurendava toimega, nt MDMA (*ecstasy*);
- dissotsiatiivid ja psühheedeelikumid – tunnetust ja taju muutva toimega, nt LSD, ketamiin;

- opioidid – eufooriat tekitava toimega, nt heroiin, fentanüül, nitaseenid.

Kriisiderohkes maailmas on palju probleeme ja nendega toimetuleku viisid on erinevad. Tarvitamise põhjusest olenemata on kindel, et uimastid on paratamatult saanud tänapäevase maailma osaks. Viimasel ajal ollakse üha enam valmis rääkima oma uimastitarvitamise kogemustest. Tänu sellele oleme hakanud paremini mõistma, et uimastite tarvitaja võib olla ka meie naaber, sõber või pereliige. Uimastite tarvitamisest avalikult rääkimine aitab lahti mõtestada, miks seda tehakse, kas ja millised riskid sellega kaasnevad ning kuidas ulatada abikäsi.

Uimastite tarvitamise põhjused ja kontekst

Uimasti tarvitamise põhjalikumaks mõistmiseks ei piisa ainult tarvitatava uimasti ja tarvitamise sageduse hindamisest. Uimastite tarvitamise lõplik mõju oleneb suuresti ka inimestest endast ja keskkonnast, kus tarvitamine toimub. Uimastite

¹ Artiklis mõeldakse edaspidi uimastite all ebaseaduslikke uimasteid ehk narkootikume.

tarvitamise põhjused on väga erinevaid (Liebregts jt 2022), need võivad esineda samal ajal (Miller jt 2011) ning võivad jääda sügavamal tasandil ebaselgeks ka tarvitajale endale (Müller ja Schumann 2011). Praktilisuse mõttes on siinkohal välja toodud kolm suuremat kategooriat, miks erinevaid uimasteid tarvitatakse.

• Rekreatiivne ehk meelelahutuslik tarvitamine

Uimasteid tarvitatakse enamasti vabal ajal (nt nädalavahetusel) ja seltskonnas, et lõbutseda, lõõgastuda, kogeda naudingut, pidutseda ja saada vaheldust argipäevast. Selline tarvitamine ei pea muutuma elu oluliseks osaks ja võib olla seotud mõne eluperioodiga, millest kasvatakse välja. Näiteks narkootikumide tarvitamise veebiuuringu alusel on kanepit tarvitatud kõige enam stressi vähendamiseks, lõdvestumiseks (74%) ning meelelahutuseks (66%) (Abel-Ollo jt 2022).

• Teraapiline tarvitamine

Uimastite tarvitamise peamine eesmärk on toime tulla mõne probleemi või negatiivse meeleseisundiga, nt vaimse või füüsilise tervise probleemid, traumad. Sageli ütlevad uimasteid tarvitavad inimesed, et teevad seda eneseraviks, näiteks siis, kui tuntakse, et mujalt ei saada abi oma probleemi lahendamiseks. Veebiuuringule vastanud kasutajatest 46% tarvitasid kanepit endi sõnul une parandamiseks ning 45% depressiooni ja ärevuse sümptomite leevendamiseks (Abel-Ollo jt 2022). Teraapilisel eesmärgil tarvitamine võib olla stabiilne ja kontrollitud, kuid võib esineda ka eskapismi ehk oma probleemide eest põgenemist, mida iseloomustab kaootilisem tarvitamismuster ja tarvitamisest tingitud kahjude suurenemine.

• Võimekust suurendav tarvitamine (ingl *enhancement*)

Uimasteid võidakse tarvitada ka oma seisundi parandamiseks või võimekuse stimuleerimiseks. Näiteks tarvitatakse stimulante, et parandada keskendumisvõimet ja töötada pikemat aega väsimata. Psühheedelikume aga tarvitatakse näiteks selleks, et avardada taju ja loovust.

Juba siin võib näha ka tarvitamismustreid, mis langevad kategooriate piirimaile: näiteks spirituaalseks ja vaimseks arenguks uimastite tarvitamine, mis võib tuleneda mõnest eelnevast traumast või tajutud puudusest, kuid läheb kaugemale pelgast probleemiga toimetulekust. Peale isiklike motiivide tuleb tarvitamise paremaks mõistmiseks arvestada ka keskkondlikke tegureid, nagu suhtlusvõrgustik (nt uimastite normaliseeritus ja kättesaadavus) või asukoht, kus uimasteid eelkõige tarvitatakse.

Põhjuseid ja konteksti teada on oluline, et mõista, mida tarvitamine konkreetsele inimesele annab.

Aastal 2021 korraldatud narkootikumide tarvitamise veebiuuring annab teavet narkootikumide tarvitamise kohtadest. Enamik vastanutest oli narkootikumide tarvitanud oma kodus (87%), millele järgnes avalik ruum (54%), muusikafestival või pidu (47%) ja klubi või baar (33%). Vastanuist 15% aga tunnistas, et teeb seda ka töökohal. Samuti andis uuring võimaluse tuua välja põhjuseid, miks valitud narkootikumi tarvitati (Abel-Ollo jt 2022).

Põhjuseid ja konteksti teada on oluline, et mõista, mida tarvitamine konkreetsele inimesele annab. Sageli piirduakse uimastitest

rääkimisel ainult võimalike riskide ja kahjudega. Kui aga uimastitel ei ole inimese jaoks ühtegi positiivset või kasulikku eesmärki, miks neid üldse tarvitatakse? Uimastite tarvitamise „kasulikkusest“ rääkimine ei tähenda, et toodud põhjendused oleksid alati adekvaatsed või kahjud poleks samuti reaalsed, kuid nende põhjenduste mõistmine aitab inimest ka paremini kõnetada ja luua talle toetamisvõimalusi. Oluline on lasta inimesel tarvitamine ise määratleda, et olla talle toeks just seal, kus ta oma elus parasjagu asub, sest kõik eespool kirjeldatud tarvitamis põhjused või -mustrid muutuvad tegelikult pidevalt.

Uimastite tarvitamise levimus

Iganenud on arusaam, et uimastite tarvitaja kuulub ühiskonna põhjakihti, on tingimata keerulise lapsepõlvega ning tõenäoliselt on tema emakeel vene keel. Levimusuuringute põhjal saab öelda, et kuni veerand 16–64-aastastest elanikest on elu jooksul tarvitanud narkootikume (Vorobjov jt 2019; Reile ja Veideman 2021). See tähendab, et iga neljas eestimaalane on kas või korra elu jooksul kanepit või muud ebaseaduslikku uimastit proovinud ja võib olla üsna kindel, et meie kõigi tutvusringkonnas on vähemalt üks neist inimestest. Enamasti piirduakse siiski narkootikumide proovimisega kord või paar, mida tavaliselt tehakse esimest korda 14–15-aastasena (Vorobjov ja Tamson 2020; Lõhmus jt 2023).

Iga neljas meie hulgast on kas või korra elu jooksul kanepit või muud ebaseaduslikku uimastit proovinud.

Korduva tarvitamise näitajateks on uurin-gutes peetud viimase 12 kuu ja 30 päeva

jooksul narkootikumide tarvitamist, kuhu võib sattuda ka esmast tarvitamist, kuid laiemalt viitavad need näitajad regulaarsemale tarvitamisele. Viimaste andmete põhjal on 16–64-aastastest 7% tarvitanud viimasel 12 kuul narkootikume ja kuni 6% teinud seda viimase 30 päeva jooksul (Vorobjov jt 2019; Reile ja Veideman 2021). Meeste seas oli narkootikumide tarvitamine levinum kui naiste hulgas ja nooremates vanuserüh-mades tunduvalt suurem kui vanemates. Kõige levinum on tarvitamine 16–24-aas-taste seas, pärast 34. eluaastat väheneb tarvitamine oluliselt (Reile ja Veideman 2021). Näiteks 2021. aastal oli 31% Eesti 14–18-aastastest noortest proovinud elu jooksul mõnd narkootikumi, neist 75% oli seda teinud korduvalt.

Noorte seas on kõige levinumad kanepi-tooted, sissehingatavad ained (nt bensiin, liim, lakk, lahusti), uinutid või rahustid arsti korralduseta ja stimulandid (Lõhmus jt 2023; Vorobjov ja Tamson 2020). Täiskasvanud tarvitavad kõige enam kanepit, millele järg-nevad arsti korralduseta rahustid või uinutid, *ecstasy*, amfetamiinid, kokaiin, LSD ja GHB (Reile ja Veideman 2021).

Narkootiliste ainete tarvitamist näitavad Eestis ka piirkondlikud reoveeuuringud (Abel-Ollo jt 2023a). Tallinna reovees olid 2022. aastal kõige levinumad narkootiku-mid kanep, kokaiin, amfetamiin ja metam-fetamiin. Võrreldes 2020. aasta reoveeuurin-guga oli kokaiini tarvitamise jääke Tallinna reovees 61% rohkem, eriti kõrged näitajad olid nädalavahetusel ja nädala esimestel päevadel. Tulemuste põhjal võib oletada, et lisaks meelelahutuslikule tarvitamisele nädalavahetusel on kokaiini tarvitamine osale inimestest igapäevane harjumus (Abel-Ollo jt 2023b). Tuginedes 2021. aasta nar-kootikumide tarvitajate veebiuuringule, oli viimase 12 kuu jooksul kokaiini tarvitanud

25% vastanutest (viimase 30 päeva jooksul 11%). Amfetamiini oli tarvitanud viimase 12 kuu jooksul 29%, *ecstasyt* 38% ja LSD-d 26%. Võrreldes 2018/2019. aasta tarvitajate veebiuuringuga oli LSD tarvitamine 2021. aastal märgatavalt levinum (Abel-Ollo jt 2022).

Tervise Arengu Instituudi algatusel käivitus 2022. aastal tasuta anonüümne ööpäev läbi töötav Narko.ee tugiliin.

Lisaks meelelahutuslikel ja muudel põhjustel tarvitajatele on Eestis arvestatav hulk narkootikumide süstivaid inimesi (NSI) (Raag jt 2019). Narkootikumide süstijate keskmine vanus on aastast aastasse tõusnud ja nende süstimisstaaž pidevalt pikenenud: 2020. aasta uuringus oli NSI keskmine vanus 37 ja süstimisstaaž 18 aastat. Peamised süstitavad narkootikumid olid kuni 2017. aastani piirkonnast olenevalt fentanüül või amfetamiin (Salekešin ja Vorobjov 2019 ja 2021).

Viimastel aastatel on fentanüüli kättesaadavus ja puhtus vähenenud ning peamised süstitavad ained on olnud amfetamiin, katinoonid, metamfetamiin ja opioidisõltuvuse asendusravil kasutatavad ravimid (ravimite väärkasutus) (Abel-Ollo jt 2022 ja 2023). Sünteetilistest opiididest on alates 2019. aastast kuni siiani lisandunud Eesti narkoturule ülikanged nitaseenid (isotonitaseen, metonitaseen ja protonitaseen). Neid nitaseenide ainerühma kuuluvaid aineid on tuvastatud nii kasutatud süstalde süstlajääkide uuringus (Abel-Ollo jt 2022 ja 2023) kui ka narkootikumide üledoosist põhjustatud surmajuhtude aineluueteludes. Nitaseenide tarvitamine tõi 2022. aastal kaasa surmajuhtude hüppelise tõusu narkootikumide üledooside tõttu, mis

viimastel aastatel oli jõudsalt vähenenud. Aastal 2021 oli 39 narkootikumide üledoosist põhjustatud surma, 2022. aasta andmete kohaselt aga üle 80 sellise juhu (Surma põhjuste registri andmed 2023).

Lisaks uutele nitaseenidele tõi 2022. aasta Eesti narkoturule ka seadusega reguleerimata poolsünteetilise kannabinoidi, heksahüdrokannabinooli ehk HHC (EKEI andmed 2022). HHC-d võidakse turustada nii kanepiõisikute, veipide kui ka maiustuste (nt kummikommid) ja teiste toiduainete lisandina. HHC-l arvatakse olevat umbes 70–80% looduslikule kanepile psühhotroopse toime andva kannabinoidi tetrahüdrokannabinooli (THC) tugevusest. HHC suuremad annused kutsuvad esile THC-ga sarnase eufoorilise psühhoaktiivse mõju (EMCDDA 2022).

Teenused

Mõnikord soovivad inimesed, kes proovivad uimasteid esimest korda või tarvitavad neid juba korduvalt ja pikema aja jooksul, selle üle kellegagi arutleda, olgu jutuaineks ainete koosmõju, turule tulnud uued ained, mõju tervisele, soov sõltuvusest vabaneda, mure lähedase pärast vms. Kui muidu pöördutakse murega esmajärjekorras pere liikmete poole, siis seda küsimust üritatakse nende eest sageli pigem varjata. Infot otsitakse peamiselt internetist ja sõpradelt, kellel teatakse olevat varasemaid kokkupuuteid uimastitega. Niisugune info aga ei ole alati abiks, et selle põhjal valikuid teha, ega pruugi olla teaduspõhine.

Tervise Arengu Instituudi algatusel käivitus 2022. aastal tasuta anonüümne ööpäev läbi töötav Narko.ee tugiliin, kuhu võib pöörduda eesti või vene keeles, helistades lühinumbril 1747, numbril 641 4110, kirjutades e-postil 1747@narko.ee või vestlusakna kaudu leheküljel narko.ee. Tugiliini

vaimse tervise spetsialistid ei anna hinnanguid ega mõista hukka ühtegi narkootikumidega seotud küsimust ega inimest. Nad kuulavad ja oskavad neil teemadel kaasa mõelda. Julgustame sinna pöörduma, kui inimene ei tea, millest või kellest alustada, kuid küsimus hingel kripeldab.

Tugiisikud töötavad praegu Harjumaal, Ida- ja Lääne-Virumaal ning alates detsembrist 2022 ka Tartumaal.

Tugiisikuprogrammi Sütik võivad pöörduda inimesed alates 18. eluaastast, kes vajavad narkootikumide tarvitamise tõttu tekkinud raskutega toimetulekuks emotsionaalset tuge, abi ametiasutustega suhtlemisel või raviasutusse pöördumisel. Osa tugiisikutest on ise läbinud pika teekonna narkootikumide proovimisest sõltuvuse ja tervenemiseni ning mõistavad samas olukorras olijate muresid seetõttu väga hästi. Tugiisikute hulgas on ka sotsiaaltöö haridusega inimesi, kes valdavad nii eesti kui ka vene keelt. Programmi juht võtab alati arvesse helistaja murede olemust, tema sugu, vanust ja emakeelt ning koos otsustatakse, kes võiks olla talle parim toetaja. Kui koostöö siiski ei laabu, saab tugiisikut ka vahetada. Tugiisikud töötavad praegu Harjumaal, Ida- ja Lääne-Virumaal ning alates detsembrist 2022 ka Tartumaal.

Kanep on Eestis kõige levinum narkootikum, seetõttu on välja töötatud eraldi programm Valik neile täiskasvanutele, kes soovivad oma kanepitarvitamise harjumuste üle nõustajaga veebis või kohapeal konfidentsiaalselt arutleda. Nõustajad ei küsi inimeselt ainult tema kanepitarvitamise kohta, vaid püüavad koos inimesega vaadata palju suuremat pilti: leida üles põhjused, miks

on kanepit tarvitama hakatud ehk mis on selle taga. Koos püütakse mõelda, kas kanep asendab lähedussuhet, aitab lõõgastuda või parandab inimese arvates tema seksuaalelu. Kaalutakse alternatiive ja otsustatakse koos, kas kanepi tarvitamise vähendamine või lõpetamine võiks inimese enda hinnangul tema elu positiivses suunas mõjutada. Kui inimene on valmis, liigutakse koos muutuste suunas. Tasuta kohtumisi nõustajaga võib olla kuni kuus.

Olgugi et kanep ja stimulandid on kõige enam levinud uimastid, on eraldi abivõimalused loodud ka opioidide tarvitajatele. Inimene, kes on pikema aja vältel opioide süstides tarvitanud ja tal on välja kujunenud sõltuvus, vajab üldjuhul oma eluga toime tulemiseks kõrvalist tuge. Seda pakuvad kahjude vähendamise keskused, kus saab hinnanguvabalt suhelda kogemusnõustajaga, kasutada sotsiaaltöötaja või psühholoogi nõustamist ja paluda tasuta tarvikuid (nt süstlad, kondoomid), mis tõkestavad nakkushaiguste ja teiste infektsioonhaiguste levikut.

Kui opioide tarvitav inimene on valmis pöörduma ravile, saab psühhiaater määrata talle opiodi asendusravi. Asendusravimina on Eestis kasutatud metadooni, mida manustatakse vedelal kujul. Alates 2023. aastast on asendusravimina kasutusel ka tabletina manustatav buprenorfiin, mis osale patsientidest annab paremaid ravitulemusi.

Kõigi Eestis kättesaadavate teenuste kohta uimasteid tarvitavatele inimestele saab lähemalt lugeda narko.ee lehelt.

Kokkuvõte

Uimastite maailm võib tunduda kaugel ja võõras seni, kuni nendega ise mingil moel kokku puututakse. Uuringud näitavad, et uimastite tarvitamine muutub üha laialuluslikumaks, mistõttu nendest teadlik

olemine on tähtis nii ennetusvaldkonnas, ravis kui ka lihtsalt sõpra või pereliiget nõustades. Oluline on julgeda uurida, küsida ja vajadusel ka abi otsida. Nagu ikka algab

maailma muutmine iseendast: märgates oma mõttemustreid ja neid vajadusel korrigerides, teeme rohkem head, kui esmapilgul tunduda võib.



Viidatud allikad

- Abel-Ollo, K., Lõhmus, L., Kurbatova, A. (2022). *Narkootikumide tarvitamise veebiküsitlus 2021*. Tallinn: Tervise Arengu Instituut.
- Abel-Ollo, K., Riikoja, A., Barndõk, T., Kurbatova, A. (2023a). *Tallinna ja Kõhla-Järve piirkonna reovee uuring uimastite jääkide suhtes 2022*. Tallinn: Tervise Arengu Instituut.
- Abel-Ollo, K., Riikoja, A., Barndõk, T., Kurbatova, A., Murd, A. (2023b). *Eesti kahjude vähendamise teenuste osutamisel kogutud süstalde uuring narkootikumide jääkide suhtes*. Tallinn: Tervise Arengu Instituut.
- Abel-Ollo, K., Riikoja, A., Barndõk, T., Kurbatova, A., Murd, A. (2021). *Tallinna ja Narva linna kahjude vähendamise keskustes kogutavate süstalde uuring narkootikumide jääkide suhtes*. Tallinn: Tervise Arengu Instituut.
- EMCDDA. (2022). *EMCDDA technical expert meeting on hexahydrocannabinol (HHC) and related cannabinoids*. www.emcdda.europa.eu/news/2022/emcdda-technical-expert-meeting-hexahydrocannabinol-hhc-and-related-cannabinoids_de (28.04.2023).
- Liebrechts, N., McGovern, W., Spencer, L., O'Donnell, A. (2022). No Thanks! A Mixed-Methods Exploration of the Social Processes Shaping Persistent Non-Initiation of Amphetamine-Type Stimulants. *Contemporary Drug Problems*, 00914509221084388. doi:10.1177/00914509221084388
- Lõhmus, L., Tamson, M., Pertel, T., Abel-Ollo, K. (2023). *Eesti noorte seksuaaltervis: teadmised, hoiakud ja käitumine. Kokkuvõte*. Tervise Arengu Instituut. www.tai.ee/sites/default/files/2023-01/Kokkuv%C3%B5te_NU2021_28092022.pdf (28.04.2023).
- Miller, W. R., Forcehimes, A., Zweben, A. (2011). *Treating addiction: A guide for professionals*. Guilford Press.
- Müller, C. P., Schumann, G. (2011). Drugs as instruments: A new framework for non-addictive psychoactive drug use. *Behavioral and Brain Sciences*, 34(6), 318–319. doi:10.1017/S0140525X11000756
- Raag, M., Vorobjov, S., Uusküla, A. (2019). Prevalence of injecting drug use in Estonia 2010–2015: a capture-recapture study. *Harm Reduct J*, 16(19). doi:10.1186/s12954-019-0289-3.
- Reile, R., Veideman, T. (2021). *Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2020*. Tallinn: Tervise Arengu Instituut.
- Salekešin, M., Vorobjov, S. (2019). *HIV levimuse ja riskikäitumise uuring Narva narkootikumide süstivate inimeste seas 2018*. Tallinn: Tervise Arengu Instituut.
- Salekešin, M., Vorobjov, S. (2021). *HIV-i levimuse ja riskikäitumise uuring narkootikumide süstivate inimeste seas Kõhla-Järvel 2020*. Tallinn: Tervise Arengu Instituut.
- Vorobjov, S., Salekešin, M., Vals, K. (2019). *Eesti täiskasvanud rahvastiku uimastite tarvitamise uuring*. Tallinn: Tervise Arengu Instituut.
- Vorobjov, S., Tamson, M. (2020). *Uimastite tarvitamine koolinoorte seas: tubakatoode, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine Eesti 15–16-aastaste õpilaste seas*. Tallinn: Tervise Arengu Instituut.